

ことに注意すべきである。LDH は、間質性肺炎に対する疾患特異性は低い³⁾が、肺疾患発症から上昇までの時間が短いため、間質性肺炎急性増悪の早期診断に有用性がある。これらのバイオマーカーの高値は、急性呼吸窮迫症候群でも認められる。最近、末梢血単球数が特発性肺線維症の進行、死亡、入院率などの予後と関連するバイオマーカーである可能性が示されている³⁾。

iv) 肺サルコイドーシス

30～60 % の症例でアンジオテンシン転換酵素 (angiotensin converting enzyme : ACE) の高値が認められ、診断に有用である⁶⁾。

v) 肺血栓塞栓症

肺血栓塞栓症は胸部造影 CT によって診断されるが、凝固能亢進時に上昇するフィブリン分解産物である D-ダイマーがスクリーニング検査として有用である。Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria (PERC) は、肺血栓塞栓症 (PE) の臨床的可能性が低いと判断された患者に対し、D-ダイマー検査や造影 CT の不要性を判断するためのスクリーニングツールである。PERC の 8 項目すべてに該当しない場合 (すべて陰性) には、D-ダイマー検査を行わずに PE を除外できる。一方、ひとつでも該当項目があれば D-ダイ

マー検査を行い、陽性であれば造影 CT を施行する。

vi) 肺高血圧症

肺高血圧症の診断には、右心カテーテル検査が必要であるが、スクリーニング検査として、血中脳性ナトリウム利尿ペプチド (brain natriuretic peptide : BNP)、尿酸値上昇がスクリーニング検査として有用である。BNP 値は、左心不全以外でも、肺高血圧症による右心不全でも高値となる。腎不全症例でも高値となることに注意する。

文 献

- 1) Ortega HG, et al : N Engl J Med 371 : 1198, 2014
- 2) 日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会 (編) : COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン、第 6 版、メディカルレビュー社、2022
- 3) Kreuter M, et al : Am J Respir Crit Care Med 204 : 74, 2021
- 4) Milgrom H, et al : N Engl J Med 341 : 1966, 1999
- 5) 日本呼吸器学会びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン作成委員会 (編) : 特発性間質性肺炎診断と治療の手引き 2022 (改訂第 4 版)、南江堂、2022
- 6) 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会 (編) : サルコイドーシス診療の手引き 2023、克誠堂出版、2023
- 7) Kline JA. Thromb Res 163 : 207, 2018